

¿Qué es la depresión?

No es debilidad, no es flojera, no es una elección. Es un trastorno tratable.

— LA DEPRESIÓN NO ES TRISTEZA NORMAL

Todos nos sentimos tristes a veces. La diferencia es que en la depresión ese estado de ánimo es **persistente, intenso y afecta el funcionamiento** en múltiples áreas de la vida. No “se pasa solo con querer”, y no significa que la persona sea débil.

— ¿CÓMO SE MANIFIESTA LA DEPRESIÓN?

● EN EL CUERPO

- Fatiga constante
- Cambios en el sueño
- Cambios en el apetito
- Pesadez corporal
- Dolores difusos
- Falta de energía

● EN LOS PENSAMIENTOS

- Autocrítica intensa (“no sirvo para nada”)
- Desesperanza
- Dificultad para concentrarse
- Pensamientos de muerte
- Culpa excesiva

● EN LA CONDUCTA

- Aislarse de otros
- Dejar de hacer cosas
- Descuidar el autocuidado
- Postergación, ruptura de rutinas
- Retirada de actividades placenteras

— LO QUE LA DEPRESIÓN TE HACE CREER (Y NO ES VERDAD)

“No voy a mejorar nunca.”

La depresión tiene tratamiento efectivo. Mejorar es posible, aunque el proceso lleve tiempo.

“Es culpa mía por no tener fuerza de voluntad.”

No es una elección ni un defecto de carácter. Es un trastorno con base biológica, psicológica y social.

“A otros les va peor, no tengo derecho a sentirme así.”

El sufrimiento no se mide por comparación. Lo que sentís es válido, más allá de las circunstancias.

“Molestar a los demás con esto no vale la pena.”

Pedir ayuda es una forma de cuidarse, no una carga. La depresión empeora en el aislamiento.

PARA REFLEXIONAR

¿Qué cosas de las que leíste resonaron con tu experiencia? ¿Hay alguna creencia sobre la depresión que te esté afectando?

Depresión y riesgo suicida

La evaluación del riesgo suicida es una competencia clínica central. Esta guía orienta la evaluación, el manejo y los criterios de derivación o intervención urgente.

NOTA CLÍNICA IMPORTANTE

Esta guía es un recurso de orientación clínica general, no un protocolo estandarizado. Ante cualquier situación de riesgo real, seguí los protocolos institucionales vigentes, consultá con supervisión clínica y actuá con criterio profesional contextualizado.

1 · ESPECTRO DE LA IDEACIÓN SUICIDA

Ideación pasiva	Deseos de no existir o de “no estar”. Sin plan ni intención activa.
Ideación activa sin plan	Pensamientos activos de suicidarse, sin un método o momento definido.
Ideación con plan	Pensamientos activos con un método, lugar o momento pensado.
Intención o preparación	Decisión tomada. Preparativos concretos. Riesgo inminente.

2 · FACTORES A EVALUAR

FACTORES DE RIESGO

- Intentos previos (principal predictor)
- Plan específico y acceso a medios
- Desesperanza intensa
- Aislamiento social
- Consumo de sustancias
- Impulsividad elevada
- Pérdidas recientes significativas

FACTORES PROTECTORES

- Red de apoyo social activa
- Razones para vivir (familia, proyecto, fe)
- Acceso a tratamiento y buena alianza terapéutica
- Capacidad de buscar ayuda
- Ausencia de acceso a medios letales
- Compromiso con la seguridad

3 · EVALUACIÓN CLÍNICA DIRECTA

Preguntar directamente sobre suicidio **no aumenta el riesgo**. La evaluación directa y sin rodeos facilita que la persona se sienta escuchada. (Preguntas en la página siguiente.)

— 3 · PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN DIRECTA

- ¿Has tenido pensamientos de hacerte daño o de no querer seguir viviendo?
- ¿Con qué frecuencia tenés esos pensamientos? ¿Son muy intensos?
- ¿Has pensado en cómo lo harías?
- ¿Tenés acceso a ese medio?
- ¿Has llegado a preparar algo o a ponerte en una situación de riesgo?
- ¿Hay algo que te impide actuar? ¿Qué razones tenés para seguir adelante?

— 4 · INTERVENCIÓN URGENTE O DERIVACIÓN

Intervención urgente ante: plan específico con acceso a medios, intención activa o preparativos concretos, estado de agitación o intoxicación que comprometa la seguridad, ausencia de red de apoyo inmediata. En estos casos: **no dejar sola a la persona, contactar red de apoyo y derivar a guardia de salud mental.**

— 5 · PLAN DE SEGURIDAD (SIN RIESGO INMINENTE)

- Identificar señales de alerta tempranas personales.
- Estrategias de manejo interno: qué puede hacer la persona cuando aparecen esos pensamientos.
- Personas de confianza a quienes puede llamar.
- Recursos profesionales de emergencia (línea de crisis).
- Restricción de acceso a medios letales (acuerdo con familia si es necesario).

— REGISTRO CLÍNICO

Evaluación de riesgo en esta sesión (nivel, factores identificados):

Acuerdos y plan de seguridad establecidos:

Tareas para el estado de ánimo

Herramientas para trabajar la depresión y los bajones

1 · 2

1 De momento, no mejores

A veces, forzarte a sentirte bien empeora las cosas. Esta tarea es diferente: por ahora, date permiso para estar como estás.

¿CÓMO HACERLO?

1. Cuando notes que te estás exigiendo sentirte mejor de lo que te sentís, pausá.
2. Decite: "Por ahora, está bien sentirme así. No necesito apurarme."
3. No estás obligado/a a mejorar de golpe. El proceso tiene su tiempo.

Darte permiso para sentirte mal no es rendirse. Es dejar de gastar energía en pelear contra lo que es.

2 Planificá un día perfecto

La noche anterior, diseñá cómo sería tu día ideal mañana. ¿Qué harías? ¿Con quién? ¿Qué evitarías? Al final del día, evalualo del 1 al 10.

¿CÓMO HACERLO?

1. Antes de dormir, escribí: ¿cómo sería mi día ideal mañana? (actividades, personas, momentos).
2. Sé específico/a: horarios, lugares, detalles.
3. Al final del día siguiente, ponele un número del 1 al 10.
4. ¿Qué estuvo bien? ¿Qué cambiarías para mañana?

No se trata de un día perfecto real — se trata de que vos estés al mando de cómo lo vivís.

3 Escribir mensajes negativos (y después soltarlos)

Durante 30 minutos, escribí todos los mensajes negativos que recibiste o que te decís. Al terminar, quemalos o rompelos. Después, en 10 minutos, escribí mensajes positivos.

¿CÓMO HACERLO?

1. Parte 1 (30 min): escribí todos los mensajes negativos — de otros, de vos mismo/a. Sin filtro.
2. Cuando suene el timer, quemá o rompé esos papeles.
3. Parte 2 (10 min, en otro lugar): escribí mensajes positivos sobre vos. No tenés que creerlos todavía.
4. Guardá los positivos en un lugar seguro.

No es necesario creer los mensajes positivos al principio. Solo leerlos con la mano no dominante ayuda a registrarlos diferente.

4 Adiós depresión, hola nueva versión

Escribí dos cartas: una de despedida a la depresión o a los bajones, y una de bienvenida a la persona que estás construyendo.

¿CÓMO HACERLO?

1. **Carta 1 — Despedida:** escribible a la depresión. Agradecele si algo te enseñó. Contale que ya no la necesitás.
2. **Carta 2 — Bienvenida:** escribite a vos mismo/a. ¿Quién sos ahora? ¿Qué va a ser diferente?
3. Sé lo más específico/a que puedas en ambas.

Estas cartas son para vos. No tienen que estar “bien escritas” — tienen que ser genuinas.

5 La carta para los días malos

En un día que te sentís relativamente bien, escribite una carta para cuando venga un bajón. Incluí tus fortalezas y qué te ayuda.

¿CÓMO HACERLO?

1. Agarrá papel y lapicera cuando estés en un día medianamente bien.
2. Escribí: “Querido/a [tu nombre], si estás leyendo esto es porque las cosas están difíciles ahora...”
3. Incluí: qué fortalezas tenés, qué te ayudó antes, palabras amables para ese momento.
4. Guardala en un sobre y abrila solo cuando la necesitás.

Tu versión de los días buenos tiene sabiduría que tu versión de los días malos necesita. Esta carta es ese puente.

El círculo de la inactividad

Por qué a veces cuesta tanto volver a moverse

Cuando estás pasando por un momento difícil, es común caer en un patrón que se repite una y otra vez.

Entender este patrón es el **primer paso para empezar a romperlo**.



La buena noticia es que se puede entrar a este círculo desde cualquier punto **y romperlo**. No hace falta esperar a sentirse mejor para actuar: alguna acción pequeña, aunque no haya ganas, es lo que empieza a cambiar el ciclo.

PARA RECORDAR

No se trata de saltar del primer al último escalón. Se trata de un paso pequeño, sostenible, que interrumpa el patrón aunque sea un poco.

Evaluación de inicio

¿Dónde estoy hoy? — línea de base de tratamiento

Antes de empezar a trabajar, es útil saber desde dónde partís. No hay respuestas correctas ni incorrectas — **solo honestidad con vos mismo/a.**

— ENCERRÁ EL NÚMERO QUE MEJOR TE REPRESENTA HOY

Energía	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ánimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Motivación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sentido de vida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Conexión social	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Satisfacción general	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LAS TRES SITUACIONES QUE MÁS PESO ME GENERAN HOY

1 _____

2 _____

3 _____

ACTIVIDADES QUE ANTES DISFRUTABA (AUNQUE HOY NO LAS SIENTA)

1 _____

2 _____

3 _____

PARA RECORDAR

Esta evaluación no busca diagnosticarte por tu cuenta. Es un punto de partida para conversar con tu psicóloga o psicólogo y armar un plan juntos.

Cierre y prevención de recaída

Mirando hacia atrás, preparándome hacia adelante

Llegar a este punto del proceso **merece reconocerse**. Esta ficha ayuda a revisar el camino recorrido y a dejar por escrito qué hacer si en el futuro el ánimo vuelve a bajar.

— COMPARANDO EL INICIO Y EL CIERRE

ÁREA	AL EMPEZAR	HOY
Ánimo (1-10)		
Energía (1-10)		
Motivación (1-10)		
Conexión social (1-10)		

MIS REFLEXIONES DE CIERRE

¿Qué fue lo más significativo de este proceso?

¿Qué herramienta aprendida quiero seguir usando?

¿Qué obstáculo se repitió, y qué aprendí de él?

MIS SEÑALES DE ALERTA TEMPRANA

¿Qué cambios en tu sueño, ánimo o conducta suelen ser las primeras señales de que algo se está complicando de nuevo?

1

2

QUÉ VOY A HACER SI NOTO ESAS SEÑALES

PARA RECORDAR

Una recaída no borra el progreso hecho. Volver a pedir ayuda en ese momento es tan valioso como haberlo hecho la primera vez.